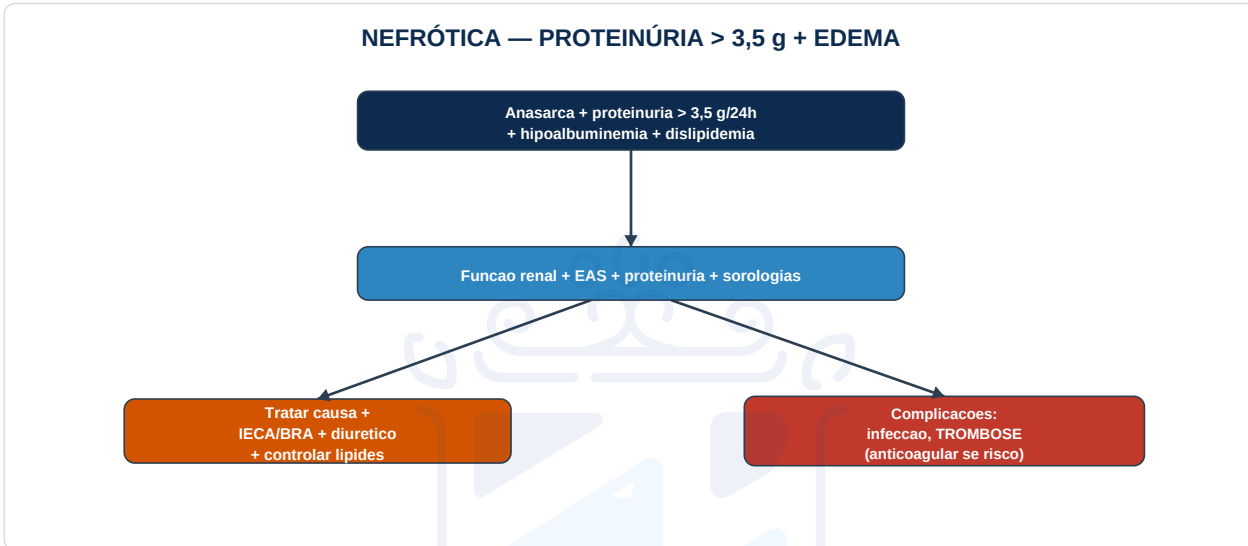


SÍNDROME NEFRÓTICA — PROTEINÚRIA MACIÇA

FLUXOGRAMA — ABORDAGEM



DEFINIÇÃO

O QUE É

- Glomerulopatia por LESÃO DA BARREIRA DE FILTRAÇÃO glomerular
- Tétrade: proteinúria maciça (> 3,5 g/24h) + hipoalbuminemia + anasarca + dislipidemia
- Primária: lesão mínima, glomeruloesclerose segmentar e focal (GESF), membranosa
- Secundária: diabetes, lúpus, amiloidose, infecções crônicas (HIV, hepatite B)

QUADRO CLÍNICO

APRESENTAÇÃO

- ANASARCA (edema generalizado, mole, frio, depressível)
- Proteinúria maciça (> 3,5 g/24h) — urina espumosa
- Hipoalbuminemia e hiperlipidemia (dislipidemia)
- Fadiga e mal-estar
- Maior suscetibilidade a infecções (perda urinária de imunoglobulinas)

EXAMES — ESSENCIAIS x VARIÁVEIS

Essenciais	Variáveis (etiologia)
Hemograma, função renal, eletrólitos	Sorologias: HIV, hepatites B e C
Gasometria; sumário de urina	USG renal (tamanho, ecogenicidade, morfologia)
Proteinúria (isolada ou 24h), creatinina urinária	Glicemia/HbA1c (DM), FAN/anti-DNA (lúpus)
Albumina, perfil lipídico	Biópsia renal (define o tipo histológico e o tratamento)

RED FLAGS — COMPLICAÇÕES

VIGIAR

- TROMBOEMBOLISMO (estado de hipercoagulabilidade — perda de antitrombina): TVP, TEP, trombose de veia renal
- Infecções (perda de imunoglobulinas): peritonite primária (pneumococo), celulite, sepse
- Injúria renal aguda (hipovolemia por edema/diurético excessivo ou doença de base)
- Crise de hipovolemia x sobrecarga — avaliar a volemia antes de diurético agressivo
- Dislipidemia acentuada e desnutrição proteica nos quadros arrastados

TRATAMENTO NO PS

Rx CAUSA + SINTOMAS + COMPLICAÇÕES

Causa específica: primária/idiopática -> corticoide ± imunossupressor (conforme histologia, com nefrologia)

secundária -> tratar a base (controle do DM, lúpus; suspender nefrotóxicos)

Controle: IECA/BRA (reduz proteinúria e protege o rim) + diurético para edema/sobrecarga

Complicações: anticoagulação se alto risco/trombose; tratamento precoce de infecções (+ vacinação)

Dislipidemia: dieta + estatina se necessário

Dieta: restrição moderada de sódio; ajuste de proteína (evitar deficiência e sobrecarga)

ALTA E PRESCRIÇÃO PARA CASA

ALTA SE

- ☐ Estabilidade hemodinâmica e volemia ajustada
- ☐ Causa subjacente identificada e em tratamento
- ☐ Sem complicação aguda (trombose, infecção grave, IRA descompensada)
- ☐ Casa: diurético + IECA/BRA (se tolerar) + tratamento específico da causa
- ☐ Acompanhamento precoce com nefrologia; orientar sinais de TVP/TEP e infecção

MODELO DE ENCAMINHAMENTO

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Síndrome nefrótica: anasarca + proteinúria ____ g/24h + albumina ____ + dislipidemia.
- Função renal ____; sorologias ____; suspeita etiológica: ____ (primária/secundária).
- Conduta: IECA/BRA + diurético + tratamento da causa; profilaxia/tratamento de trombose e infecção.
- Encaminhamento à nefrologia para biópsia e definição terapêutica.

SM24
Suporte do Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Paciente com anasarca, urina espumosa, proteinúria de 6 g/24h, albumina 2,0 e colesterol elevado. Diagnóstico?

- A) Síndrome nefrítica
- B) Síndrome nefrótica
- C) Insuficiência cardíaca isolada
- D) Cirrose hepática
- E) Infecção urinária

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual complicação tromboembólica é típica da síndrome nefrótica?

- A) Trombose de veia renal (e TVP/TEP), por perda urinária de antitrombina
- B) Embolia gordurosa
- C) Trombose arterial mesentérica exclusiva
- D) Nenhuma, pois há tendência a sangramento
- E) Apenas trombose de seio cavernoso

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Por que pacientes com síndrome nefrótica têm maior suscetibilidade a infecções?

- A) Por excesso de imunoglobulinas
- B) Pela perda urinária de imunoglobulinas (e fatores do complemento)
- C) Por hipercalemia
- D) Por hiperalbuminemia
- E) Por desidratação isolada

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Qual medicação reduz a proteinúria e protege a função renal na síndrome nefrótica?

- A) AINES
- B) IECA ou BRA
- C) Antibiótico
- D) Corticoide tópico
- E) Diurético poupador de potássio isolado

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Qual exame define o tipo histológico e orienta o tratamento da síndrome nefrótica primária?

- A) Urocultura
- B) Biópsia renal
- C) Radiografia de abdome
- D) Cintilografia renal
- E) Cistoscopia

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Proteinúria maciça (>3,5 g/24h) + hipoalbuminemia + anasarca + dislipidemia é a tétade da síndrome nefrótica, por lesão da barreira de filtração glomerular (urina espumosa).

QUESTÃO 2 → Resposta: A

A síndrome nefrótica é estado de hipercoagulabilidade (perda urinária de antitrombina), predispondo a TVP, TEP e, classicamente, trombose de veia renal — justifica anticoagulação em pacientes de alto risco.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

A perda urinária de imunoglobulinas (e de fatores do complemento) aumenta a suscetibilidade a infecções, como peritonite primária por pneumococo e celulite — daí a importância da vacinação e do tratamento precoce.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

IECA/BRA reduzem a proteinúria (efeito hemodinâmico intraglomerular) e protegem a função renal, sendo pilar do manejo da síndrome nefrótica, associados ao tratamento da causa.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

A biópsia renal define o tipo histológico (lesão mínima, GESF, membranosa) e orienta o tratamento imunossupressor na síndrome nefrótica primária, conduzida pela nefrologia.

SM24
Suporte ao Plantão Médico